

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5785/2540

นาง มยุรีย์ เตวียะ
สำนักงาน ประกัน สังคม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 46 วรรคสาม, มาตรา 95, มาตรา 104

พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 38, มาตรา 40

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 มาตรา 38 และมาตรา 40มิได้บัญญัติให้การที่กรรมการแพทย์ผู้หนึ่งทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะเป็นการไม่ชอบ เพราะไม่มีบทบัญญัติว่าความเห็นของกรรมการการแพทย์จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย์เสียก่อนจึงจะเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ เพียงแต่เมื่อมีปัญหาจะต้องขอคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงจะขอให้คณะกรรมการการแพทย์เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 และเมื่อรายงานผลการสอบสวนอาการเจ็บป่วยของโจทก์มิใช่การดำเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ แต่เป็นรายงานการตรวจร่างกายโจทก์ที่นายแพทย์ส.กระทำขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารพิษในร่างกายของโจทก์ หากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นว่าความเห็นดังกล่าวเพียงพอที่จะวินิจฉัยคำร้องขอของโจทก์ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องนำเข้าปรึกษาคณะกรรมการการแพทย์ โดยนำรายงานดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ และตามมาตรา 38 วรรคสอง บัญญัติให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีแต่งตั้ง

ตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ ดังนี้ เมื่อคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนเห็นว่าเรื่องใดควรจะมอบหมายให้แพทย์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในคณะ
กรรมการการแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคที่จะต้องวินิจฉัยว่ามีลักษณะอาการ
อย่างไรก็อาจจะนำความเห็นของแพทย์ผู้นั้นมาพิจารณาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได้
ดังนั้นรายงานผลการสอบสวนอาการเจ็บป่วยที่ ส.ทำขึ้นและนำเสนอให้คณะ
กรรมการกองทุนเงินทดแทนพิจารณาจึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 40 ในประเด็น
ข้อที่ว่า มีเหตุที่จะเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามฟ้อง
หรือไม่ ศาลแรงงานได้วินิจฉัยพยานโจทก์แล้วเห็นว่าการที่โจทก์มีปริมาณสารอะลู
มินาเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณสูงหลังจากที่ไม่ได้สัมผัสกับสารเช่นนี้ไม่สอดคล้องด้วย
เหตุผล อีกทั้งได้ความจาก ย.พยานศาลและนายแพทย์ส.ว่าสารอะลูมินานี้มีอยู่ทั่วไป
ในภาวะแวดล้อมหากเก็บตัวอย่างไม่ดีอาจมีการปนเปื้อนสารอะลูมินา จากภายนอก
ได้ง่าย การที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปรากฏว่าโจทก์มีปริมาณสารอะลูมินาอยู่
ในร่างกายสูงจนผิดไปจากปกติมากเช่นนี้จึงอาจเกิดจากการปนเปื้อนของสารอะลู
มินาที่มีอยู่ในภาวะแวดล้อมในขณะที่จัดเก็บก็ได้ ลำพังผลการตรวจหาสารอะลูมินาใน
ร่างกายของโจทก์ที่มีปริมาณสูงจนผิดปกติเพียงอย่างเดียว ไม่อาจยืนยันเด็ดขาดได้
ว่าอาการป่วยของโจทก์เกิดจากสารอะลูมินาจากการทำงาน ส่วนพยานบุคคลที่จำเลย
นำเสนอล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญเมื่อรับฟังประกอบกับเอกสารทางวิชาการ
ของต่างประเทศเกี่ยวกับสารอะลูมินาตามเอกสารหมายเลข 35 และ 36 แล้วเห็นว่า
มีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์เจ็บป่วยโดยมี
อาการปวดศีรษะ อ่อนเพลียปวดตามข้อขาตามแขนและมือจริง แต่การเจ็บป่วยดัง
กล่าวไม่ได้เกิดจากสารอะลูมินาจากการทำงาน ดังนี้ เมื่อศาลแรงงานได้นำข้อนำเสนอ
ของทั้งสองฝ่ายมาวินิจฉัยโดยละเอียด มิใช่ฟังเฉพาะเอกสารหมายเลข 35 และ 36 ที่
เป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้น การนำเอกสารทั้งสองฉบับมาถ่วงอ้างเป็นส่วนหนึ่งใน
เหตุผลแห่งการวินิจฉัยย่อมกระทำได้ ไม่ทำให้การวินิจฉัยในส่วนอื่นเสียไป ตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคสามศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจว่าเห็นควรให้คู่ความฝ่ายที่ส่งเอกสารนั้นทำคำแปลที่เป็นภาษาไทย ซึ่งศาลอาจไม่สั่งให้ทำคำแปลก็ได้เช่นในกรณีที่เอกสารนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งพยานหลักฐานที่ฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้วจึงไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องสั่งให้คู่ความทำคำแปลเสมอไป การที่ศาลแรงงานมิได้สั่งให้จำเลยทำคำแปลเอกสารซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศการอ้างเอกสารดังกล่าวของฝ่ายจำเลยจึงไม่ขัดต่อกฎหมายและศาลแรงงานย่อมรับฟังเอกสารนั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนำสืบได้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104 ซึ่งอนุโลมใช้ในคดีแรงงานด้วย บัญญัติให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้นอีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่ามีให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่าหรือพยานแวดล้อมกรณี เพียงแต่มีหลักว่าให้ฟังประจักษ์พยานเป็นลำดับแรกแต่ถ้าประจักษ์พยานขัดต่อเหตุผลศาลก็อาจจะไม่รับฟังก็ได้ ส่วนพยานบอกเล่าและพยานแวดล้อมนั้น แม้จะมีน้ำหนักน้อยกว่าประจักษ์พยาน แต่ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานไม่น่าเชื่อถือ ศาลอาจฟังพยานหลักฐานอื่นได้ คดีนี้ประเด็นสำคัญที่จะต้องวินิจฉัยคือโจทก์เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหรือไม่ แพทย์ผู้ทำการตรวจร่างกายโจทก์และให้ความเห็นล้วนแต่เป็นพยานโดยตรง นายแพทย์ส.พยานจำเลยเป็นผู้หนึ่งที่ได้ตรวจร่างกายโจทก์และให้ความเห็น แม้จะได้ทำการตรวจภายหลังจากที่แพทย์หญิงช.และแพทย์หญิงอ.ได้ตรวจร่างกายโจทก์ ก็ไม่ทำให้นายแพทย์ส. มิใช่พยานโดยตรง นอกจากนี้นัก.ก็เป็นประจักษ์พยานเพราะเป็นผู้เก็บตัวอย่างฝุ่นในสถานที่ทำงานของโจทก์ไปตรวจเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานส่วนนายแพทย์ธ.ก็ได้เบิกความให้ความเห็นทางวิชาการตรงกับความเห็นของแพทย์หญิงอ. เมื่อศาลแรงงานได้นำคำเบิกความของแพทย์ผู้ตรวจร่างกายโจทก์พร้อมทั้งความเห็นของพยานดังกล่าวมาพิจารณา

ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นจึงเป็นการวินิจฉัยที่ชอบ และการที่ศาลแรงงานวินิจฉัยพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น ก็เป็นการวินิจฉัยที่ชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและบังคับให้คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนกับจำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัยจ่ายเงินให้โจทก์ตามกฎหมาย ให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 รวมกันหรือแทนกันจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนจำนวน 6,128,320 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์หย่อนสมรรถภาพในการทำงานและหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ไม่ได้ป่วยเป็นโรคพิษสารอะลูมินาสะสมในร่างกาย จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่อทำให้สารเคมีรั่วไหลหรือแพร่กระจายจนเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตราย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนเพราะจำเลยที่ 2 ได้ส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแล้วโจทก์มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาลและค่าทดแทนจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทนเท่านั้น โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ให้รับผิดชอบในมูลละเมิด ทั้งจำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 กระทำการแทนจำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าความเห็นของนายแพทย์สมพูล กฤตลักษณ์ ตามรายงานผลการสอบสวนอาการเจ็บป่วยเอกสารหมายเลข 33 เป็นการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนที่ฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 40 หรือไม่นั้นเห็นว่าพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 38 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ให้มีคณะกรรมการการแพทย์คณะหนึ่ง ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นมีจำนวนรวมกันไม่เกินสิบห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง" และมาตรา 40 บัญญัติว่า " คณะกรรมการการแพทย์มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์

(2) ให้คำปรึกษาแนะนำในทางการแพทย์แก่คณะกรรมการและสำนักงาน

(3) ให้ความเป็นต่อสำนักงานในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 13 และประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมตามมาตรา 14 และมาตรา 18(2) และ(13)

(4) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแพทย์ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย"

จากบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวไม่ปรากฏว่าการที่กรรมการการแพทย์ผู้หนึ่งทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจะเป็นการไม่ชอบเพราะ

ไม่มีบทบัญญัติว่าความเห็นของกรรมการการแพทย์จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการแพทย์เสียก่อนจึงจะเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้ เพียงแต่เมื่อมีปัญหาจะต้องขอคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการการแพทย์ คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนจึงจะขอให้คณะกรรมการการแพทย์เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 40 ทั้งตามรายงานผลการสอบสวนอาการเจ็บป่วยเอกสารหมายเลข 33 มิใช่การดำเนินงานในการให้บริการทางการแพทย์ แต่เป็นรายงานการตรวจร่างกายโจทก์ที่นายแพทย์สมพูลกระทำขึ้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสารพิษในร่างกายของโจทก์ หากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นว่าความเห็นดังกล่าวเพียงพอที่จะวินิจฉัย คำร้องขอของโจทก์ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องนำเข้าปรึกษาคณะกรรมการการแพทย์ โดยนำรายงานดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนได้และเมื่อ พิจารณารับทบทวนในมาตรา 38 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า"คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้รัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่าง ๆ" แล้ว จะเห็นว่าเมื่อคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนเห็นว่าเรื่องใดควรจะมอบหมายให้ แพทย์ซึ่งเป็นผู้หนึ่งในคณะกรรมการการแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคที่จะต้องวินิจฉัยว่ามีลักษณะอาการอย่างไร ก็อาจจะนำความเห็นของแพทย์ผู้นั้นมา พิจารณาเพื่อประกอบการวินิจฉัยได้ดังนั้นรายงานผลการสอบสวนอาการเจ็บป่วย เอกสารหมายเลข 33 ที่นายแพทย์สมพูลทำขึ้นและนำเสนอให้คณะกรรมการกองทุน เงินทดแทนพิจารณาจึงไม่ขัดต่อบทบัญญัติมาตรา 40

ปัญหาตามอุทธรณ์โจทก์ข้อต่อไปที่ว่า การที่ศาลรับฟังเอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศตามเอกสารหมายเลข 35 และ 36 โดยมีได้มีคำแปลเป็นกระบวนการพิจารณาที่ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ศาลรับฟังเอกสารดังกล่าวขัดต่อ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 วรรคสาม ซึ่งอนุโลมใช้ในคดี แรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

มาตรา 31 นั้น ในประเด็นข้อที่ว่า มีเหตุที่จะเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนตามฟ้องหรือไม่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยว่า โจทก์มีตัวโจทก์
แพทย์หญิงชิดศุภางค์ ตัจฉนิกุล แพทย์หญิงอรพรรณเมธาธิลกุล ซึ่งเป็นแพทย์ผู้
ตรวจรักษาโจทก์นายเกียรติศักดิ์ อนุไชย และนางเมตตรา ต๊ะนาถหรืออนุไชยเพื่อน
ร่วมงานกับนายประพันธ์ เติวยะ สามีโจทก์มาเบิกความเป็นพยาน มีใจความโดยสรุป
ว่า ในระหว่างทำงานกับจำเลยที่ 2 โจทก์มีอาการปวดศีรษะ ปวดข้อกระดูกและชา
ตามแขนขาจึงไปพบแพทย์ แพทย์ได้ทำการรักษาเรื่อยมาโดยแพทย์หญิงชิดศุภางค์
และแพทย์หญิงอรพรรณเห็นว่าโจทก์ป่วยเนื่องจากสารอะลูมิเนียมจากการทำงาน ซึ่ง
นายเกียรติศักดิ์และนางเมตตราเพื่อนร่วมงานของโจทก์ก็มีอาการทำนองเดียวกันกับ
โจทก์ ส่วนจำเลยมีนายแพทย์สมพล กฤตลักษณ์ อดีตรองศาสตราจารย์ประจำภาค
วิชานิติเวชและผู้อำนวยการศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลศิริราชนายแพทย์สนธยา พริ้ง
ลำภู แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ของแพทยสภา รองศาสตราจารย์กาญ
จนะ แก้งกำเนิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนาย
โสภณพงษ์โสภณ นักวิชาการแรงงาน 7 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานลาดกระบ้ง
มาเบิกความเป็นพยาน โดยนายแพทย์สมพลเบิกความยืนยันว่าได้เก็บตัวอย่างเลือด
ปัสสาวะ และเส้นผมของโจทก์ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่าโจทก์มีสา
ระอะลูมิเนียมในเลือดปัสสาวะและเส้นผมอยู่ในเกณฑ์ปกติ นายแพทย์สนธยาเบิกความ
ประกอบเอกสารทางวิชาการของต่างประเทศว่า โจทก์ไม่ได้เจ็บป่วยเนื่องจากสา
ระอะลูมิเนียมจากการทำงาน ส่วนนายโสภณเบิกความว่าได้เข้าไปเก็บตัวอย่างฝุ่นใน
สถานที่ทำงานของโจทก์และนำมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่ามีปริมาณฝุ่น
ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ เห็นว่า จำเลยที่ 2 ใช้สารอะลูมิเนียมเป็นส่วนประกอบใน
การนำแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสารอะลูมิเนียมนี้ได้ความจากรองศาสตราจารย์กาญ
จนะและนายโสภณว่า สกัดมาจากแร่บอกไซต์มีชื่อในทางเคมีว่า ALอะตอม2O
อะตอม3 (หรือAL₂O₃) มีลักษณะเป็นผงคล้ายดิน มีสภาพเป็นกลาง ไม่ทำปฏิกิริยา

กับสารอื่นไม่ละลายในน้ำหรือในสารละลายเจือจาง หากอยู่ในร่างกายจะไม่มีผลต่อร่างกายรองศาสตราจารย์กาญจนะนายแพทย์สนธยา และแพทย์หญิงอรพรรณเบิกความตรงกันว่า สารอะลูมิน่าจะไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายด้วยการสัมผัส ดังนั้นสารอะลูมิน่าจึงอาจเข้าสู่ร่างกายด้วยการหายใจและการกินสำหรับการหายใจนั้น สภาพการทำงานของโจทก์ไม่ได้สัมผัสผงอะลูมิน่าโดยตรง ชิ้นงานที่โจทก์ทำหน้าที่บัดฝุ่นเป็นอะลูมิน่าที่ได้แปรสภาพเป็นแผ่นคล้ายยางเรียกว่าแผ่นกรีนชีทแล้วหลังจากขึ้นรูปด้วยการตัดเจาะด้วยเครื่องจะมีเศษผงติดอยู่ ซึ่งฝุ่นผงดังกล่าวจะมีสภาพเป็นฝุ่นผงขนาดใหญ่ได้ความจากนายโสภณอีกว่า ฝุ่นผงที่จะเข้าสู่จมูกได้จะต้องมีขนาดเล็กกว่า 20 ไมคอนและจะเข้าสู่ส่วนลึกของร่างกายได้จะต้องมีขนาดเล็กกว่า 10 ไมคอนจะเข้าสู่ปอดได้จะต้องมีขนาดเล็กกว่า 5 ไมคอน และจะดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้จะต้องมีขนาดเล็กกว่า 1 ไมคอน ในขั้นตอนการทำงานของโจทก์ในแผนกพื้นที่ซึ่งไม่มีการใช้ความร้อนจนถึงขนาดที่จะทำให้เกิดไอโลหะที่มีอนุภาคนขนาดเล็กและเข้าสู่ร่างกายได้แม้โจทก์จะทำหน้าที่บัดฝุ่นแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์มีโอกาสมัผัสกับฝุ่นก็ตาม แต่ฝุ่นดังกล่าวมีขนาดใหญ่จึงมีโอกาสเข้าสู่ปอดและซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้น้อยมากประกอบกับผลการจัดเก็บตัวอย่างอากาศในสถานที่ทำงานของโจทก์ ซึ่งนายโสภณและเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานได้เข้าไปจัดเก็บตัวอย่างเมื่อปลายปี 2536 และปี 2537 ปรากฏว่ามีปริมาณฝุ่นรวม(TOTAL DUST) และปริมาณฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมคอน(RESPIRABLE DUST) ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งจากรายงานการตรวจร่างกายของโจทก์ ปรากฏว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโจทก์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2532 วันที่ 21 ธันวาคม 2533 วันที่ 16 ธันวาคม 2534 และวันที่ 21 พฤศจิกายน 2535 โจทก์มีปอดปกติ ดังนั้น โจทก์จึงไม่น่าจะได้รับสารอะลูมิน่าเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจจนเป็นเหตุให้เจ็บป่วย ส่วนการที่สารอะลูมิน่าเข้าสู่ร่างกายด้วยการปนเปื้อนไปกับอาหารที่กินเข้าไปนั้น ได้ความจากรองศาสตราจารย์กาญจนะ นายแพทย์สนธยา และเอกสารทางวิชาการชื่อ

ALUMINUM AND Health A Critical Review โดยศาสตราจารย์ HILLEL

1. Gitelman และ NEUROTOXICITY OF ALUMINUM โดยนาย Henry M.

Winiewski กับคณะว่าสารอะลูมินาเมื่อเข้าสู่ร่างกายด้วยการกินร่างกายจะสามารถขับสารดังกล่าวออกไปได้ โดยสารอะลูมินาสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ในปริมาณที่น้อยมาก ยกเว้นแต่ในรายผู้ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังเท่านั้นที่สารอะลูมินาอาจสะสมและมีผลต่อสมองของผู้ป่วยได้ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ไม่ปรากฏว่าโจทก์ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังแต่อย่างใด แม้โจทก์จะได้รับสารอะลูมินาเข้าสู่ร่างกายปนเปื้อนไปกับอาหารก็ไม่น่าที่จะเข้าไปสะสมในร่างกายและมีผลต่อสมองได้ อีกทั้งผลการตรวจตัวอย่างเลือดปัสสาวะ และเส้นผมของโจทก์โดยนายแพทย์สมพลก็ระบุยืนยันว่าโจทก์มีสารอะลูมินาอยู่ในเลือดปัสสาวะและเส้นผมอยู่ในเกณฑ์ปกติ ดังนั้นการที่โจทก์เจ็บป่วยโดยมีอาการเวียนศีรษะ อ่อนเพลียปวดข้อกระดูก และชาตามแขนขา ไม่น่าจะเกิดจากสารอะลูมินาจากการทำงาน ส่วนที่แพทย์หญิงจิตศุภางค์ผู้ทำการตรวจรักษาโจทก์เห็นว่าโจทก์น่าจะเจ็บป่วยเนื่องจากสารอะลูมินาจากการทำงานนั้น แพทย์หญิงจิตศุภางค์เบิกความว่าได้ให้ความเห็นโดยใช้วิธีการตรวจรักษา ชักประวัติการทำงานของโจทก์ และศึกษาเปรียบเทียบจากเอกสารทางวิชาการของต่างประเทศเท่านั้น ไม่ได้ตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่อย่างใด อีกทั้งตามใบรับรองแพทย์ เอกสารหมายเลข 21 และ 23 แพทย์หญิงจิตศุภางค์ระบุโรคว่าสงสัยพิษสะสมของสารอะลูมินา รวมทั้งอาจจะเป็นโรคจากสารโลหะหนักสะสมในร่างกาย อันเป็นความเห็นในทางสงสัยว่าอาจจะเป็นเท่านั้นหาได้ยืนยันแน่ชัดว่าโจทก์เจ็บป่วยเนื่องจากสารอะลูมินาจากการทำงานแต่อย่างใดไม่ ส่วนที่แพทย์หญิงอรพรรณทำการตรวจโจทก์แล้วเห็นว่า โจทก์มีคลื่นหัวใจและผิดปกติปกตินั้นเมื่อนายแพทย์สนธยาพยานจำเลย ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวเวชศาสตร์ได้ดูเอกสารดังกล่าวแล้วเบิกความว่าคลื่นหัวใจที่ผิดปกติไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้ป่วยได้รับสารอะลูมินาเข้าไปในร่างกายหรือไม่ และผลการตรวจปอดของโจทก์ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากคำเบิกความของ

แพทย์หญิงอรพรรณแล้วโจทก์ไม่ได้นำพยานอื่นมาสืบให้เห็นว่าปอดของโจทก์มี
อาการผิดปกติดังที่แพทย์หญิงอรพรรณอ้างแต่อย่างใด ในขณะที่ผลการตรวจร่างกาย
ของโจทก์ตามเอกสารหมาย ล.15 ตั้งแต่ปี 2532 ถึง 2535 โจทก์มีปอดที่ปกติมาโดย
ตลอด และที่แพทย์หญิงอรพรรณเบิกความว่าได้เก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของ
โจทก์ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าโจทก์มีสารอะลูมินาอยู่ในร่างกายเป็น
ปริมาณสูงนั้น ได้ความจากโจทก์ว่า โจทก์เข้าไปยังสถานที่ทำงานครั้งสุดท้ายเมื่อ
เดือนตุลาคม 2536 ต่อมาวันที่ 23 พฤศจิกายน 2536 นายแพทย์สมพลเก็บตัวอย่าง
เลือด ปัสสาวะ และเส้นผมของโจทก์ไปตรวจ ปรากฏว่ามีปริมาณสารอะลูมินาอยู่ใน
เลือด 15.9 ไมโครกรัมเปอร์เซ็นต์ ปัสสาวะ 24.6 ไมโครกรัมเปอร์เซ็นต์ แพทย์หญิง
อรพรรณเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะของโจทก์ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการในเดือน
มีนาคม 2537 กลับปรากฏว่ามีปริมาณสารอะลูมินาในเลือดสูงถึง 560 ไมโครกรัม
เปอร์เซ็นต์ในปัสสาวะสูงถึง 113 ไมโครกรัมเปอร์เซ็นต์ ทั้งที่หลังจากนายแพทย์สม
พลเก็บตัวอย่างจากร่างกายโจทก์ไปแล้วโจทก์ไม่ได้สัมผัสสารอะลูมินาจากการทำงาน
แต่อย่างใดการที่โจทก์มีปริมาณสารอะลูมินาเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณสูงหลังจากที่ไม่ได้
สัมผัสกับสารเช่นนี้ จึงไม่สอดคล้องด้วยเหตุผล อีกทั้งได้ความจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ยุวดี เชี่ยววัฒนา พยานศาลและนายแพทย์สนธยา ว่า สารอะลูมินานี้มี
อยู่ทั่วไปในภาวะแวดล้อมหากเก็บตัวอย่างไม่ดีอาจมีการปนเปื้อนสารอะลูมินาจาก
ภายนอกได้ง่าย การที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปรากฏว่าโจทก์มีปริมาณสา
รอะลูมินาอยู่ในร่างกายสูงจนผิดปกติไปจากปกติมากเช่นนี้จึงอาจเกิดจากการปนเปื้อน
ของสารอะลูมินาที่มีอยู่ในภาวะแวดล้อมในขณะที่จัดเก็บก็ได้ลำพังผลการตรวจหาสา
รอะลูมินาในร่างกายของโจทก์ที่มีปริมาณสูงจนผิดปกติเพียงอย่างเดียว ไม่อาจ
ยืนยันเด็ดขาดได้ว่าอาการป่วยของโจทก์เกิดจากสารอะลูมินาจากการทำงานพยาน
บุคคลที่จำเลยนำสืบ อันได้แก่ นายแพทย์สนธยา นายแพทย์สมพลรองศาสตราจารย์
กาญจนะ และนายโสภณ ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ เมื่อรับฟังประกอบกับ

เอกสารทางวิชาการของต่างประเทศเกี่ยวกับสารอะลูมินาตามเอกสารหมายเลข 35 และ 36 แล้ว เห็นว่ามีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอข้อเท็จจริง ฟังได้ว่าโจทก์เจ็บป่วยโดยมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลียปวดตามข้อ ขาตามแขนและมือจริง แต่การเจ็บป่วยดังกล่าวไม่ได้เกิดจากสารอะลูมินาจากการทำงาน ดังนั้น การที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนและคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยว่า โจทก์ไม่ได้เจ็บป่วยเนื่องจากสารอะลูมินาจากการทำงานจึงชอบแล้ว ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและเห็นได้ว่าศาลแรงงานกลางนำข้อนำเสนอของทั้งสองฝ่ายมาวินิจฉัยโดยละเอียดมิใช่ฟังเฉพาะเอกสารหมายเลข 35 และ 36 ที่เป็นภาษาต่างประเทศเท่านั้นการนำเอกสารทั้งสองฉบับมากล่าวอ้างเป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลแห่งการวินิจฉัยย่อมกระทำได้ ไม่ทำให้การวินิจฉัยในส่วนอื่นเสียไป นอกจากนี้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 46 วรรคสาม บัญญัติว่า "ถ้าต้นฉบับเอกสารหรือแผ่นกระดาษไม่ว่าอย่างใด ๆ ที่ส่งต่อศาลได้ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ศาลส่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทำคำแปลทั้งฉบับหรือเฉพาะแต่ส่วนสำคัญ โดยมีคำรับรองมายื่นเพื่อแนบไว้กับต้นฉบับ" จากบทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่าให้ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจว่าเห็นควรให้คู่ความฝ่ายที่ส่งเอกสารนั้นทำคำแปลที่เป็นภาษาไทย ซึ่งศาลอาจไม่สั่งให้ทำคำแปลก็ได้เช่นในกรณีที่เอกสารนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งพยานหลักฐานที่ฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นที่เพียงพอต่อการวินิจฉัยข้อเท็จจริงแล้ว จึงไม่จำเป็นที่ศาลจะต้องสั่งให้คู่ความทำคำแปลเสมอไป เมื่อศาลแรงงานกลางมิได้สั่งให้จำเลยทำคำแปลเอกสารหมายเลข 35 และ 36 ซึ่งเป็นภาษาต่างประเทศการอ้างเอกสารของฝ่ายจำเลยจึงไม่ขัดต่อกฎหมายดังที่โจทก์อ้างศาลแรงงานกลางย่อมรับฟังเอกสารนั้นในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งพยานหลักฐานที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารนำเสนอได้เทียบนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2797/2522 ระหว่างห้างหุ้นส่วนจำกัดชิงเจ้าเอ็นจิเนียร์ริงแอนด์คอนสตรัคชั่น โจทก์กรมโรงงานอุตสาหกรรม กับพวก จำเลย

ส่วนปัญหาสุดท้ายที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางมิได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานกล่าวคือมิได้วินิจฉัยตามลำดับความสำคัญของพยานหลักฐานนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 104ซึ่งอนุโลมใช้ในคดีแรงงานด้วย บัญญัติว่า "ให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่ แล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น" อีกทั้งไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติไว้ชัดแจ้งว่ามีให้ศาลรับฟังพยานบอกเล่าหรือพยานแวดล้อมกรณี เพียงแต่มีหลักว่าให้ฟังประจักษ์พยานเป็นลำดับแรก แต่ถ้าประจักษ์พยานขัดต่อเหตุผลศาลก็อาจจะไม่รับฟังก็ได้ ส่วนพยานบอกเล่าและพยานแวดล้อมกรณีนั้น แม้จะมีน้ำหนักน้อยกว่าประจักษ์พยาน แต่ถ้าศาลเห็นว่าพยานหลักฐานที่เป็นประจักษ์พยานไม่น่าเชื่อถือ ศาลอาจฟังพยานหลักฐานอื่นได้ นอกจากนี้กรณีที่โจทก์ยกมาเป็นข้ออ้างในอุทธรณ์ที่ว่าพยานฝ่ายโจทก์ที่เป็นประจักษ์พยานหรือพยานโดยตรงมีตัวโจทก์ซึ่งเจ็บป่วย แพทย์หญิงชิตศุภางค์ ตัจฉนิกุล แพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาโจทก์คนแรก แพทย์หญิงอรพรรณ เมธาติลกุล แพทย์ผู้ทำการรักษาโจทก์ต่อมาก่อนฟ้องคดีนี้ ล้วนเป็นประจักษ์พยานที่ต้องรับฟังคำเบิกความของพยานดังกล่าวเป็นลำดับแรกก่อนที่จะวินิจฉัยโดยเชื่อพยานอื่นซึ่งเป็นพยานบอกเล่าหรือพยานพฤติเหตุแวดล้อมกรณีนั้น จากคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางนั้น เห็นว่าประเด็นสำคัญที่จะต้องวินิจฉัยคือโจทก์เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานหรือไม่ แพทย์ผู้ทำการตรวจร่างกายโจทก์และให้ความเห็นล้วนแต่เป็นพยานโดยตรง นายแพทย์สมพูลพยานจำเลยเป็นผู้หนึ่งที่ได้ตรวจร่างกายโจทก์และให้ความเห็น แม้จะได้ทำการตรวจภายหลังจากที่แพทย์หญิงชิตศุภางค์และแพทย์หญิงอรพรรณได้ตรวจร่างกายโจทก์ก็ไม่ทำให้นายแพทย์สมพูลมิใช่พยานโดยตรงนอกจากนี้นายโสภณ พงษ์โสภณ ก็เป็นประจักษ์พยานเช่นกันเพราะเป็นผู้เก็บตัวอย่างฝุ่นในสถานที่ทำงานของโจทก์ไปตรวจเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนนายแพทย์สนธยา พริงลำภู ก็ได้เบิกความให้

ความเห็นทางวิชาการตรงกับความเห็นของแพทย์หญิงอรพรรณเมื่อศาลแรงงาน
กลางได้นำคำเบิกความของแพทย์ผู้ตรวจร่างกายโจทก์ พร้อมทั้งความเห็นของ
พยานดังกล่าวมาพิจารณาประกอบกับพยานหลักฐานอื่นจึงเป็นการวินิจฉัยที่ชอบแล้ว
อุทธรณ์ที่โจทก์อ้างว่าพยานฝ่ายจำเลยไม่มีประจักษ์พยานหรือพยานโดยตรงจึง
เป็นการคลาดเคลื่อนทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเมื่อวินิจฉัยมาแล้วว่าศาลมีอำนาจ
ในการวินิจฉัยพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังที่กล่าวมา การที่ศาล
แรงงานกลางวินิจฉัยพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วพิพากษาคดีไปตามนั้น จึง
เป็นการวินิจฉัยที่ชอบแล้ว

พิพากษายืน

(รวิชัย พิทักษ์พล-อัมพร ทองประยูร-บุญศรี แก้วสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ